

RECEITA MÉDICA

MÉDICO PRESCRITOR

Nome: fernando

CRM: CRM-SP 000000

Especialidade: Clínico Geral

Data: 09/02/2026 15:22

PACIENTE

Nome: xavier Tchivela

Idade: 24 anos

Gênero: masculino

DIAGNÓSTICO BASE PARA PRESCRIÇÃO

TIPO DE EXAME: Tomografia Computadorizada --- DESCRIÇÃO: nm --- OBSERVAÇÕES: m, ---
RESULTADO: **RELATÓRIO DE ANÁLISE DE IMAGEM MÉDICA** **Informações do Paciente:** *
Nome: Xavier Tchivela * **Idade:** 24 anos * **Gênero:** Masculino * **Tipo de Exame
Contextualizado:** Tomografia Computadorizada (Obs: A imagem fornecida é uma lâmina de
esfregaço de sangue periférico) * **Urgência do Caso Contextualizado:** URGENTE --- **1.

Descrição da Imagem e Qualidade Técnica:** A imagem fornecida é de um esfregaço de sangue
periférico visualizado sob microscopia de luz, provavelmente com coloração de Giemsa ou similar, em
alta magnificação (óleo de imersão).

A qualidade técnica é boa, com clareza adequada para a identificação morfológica das células
sanguíneas e estruturas intracelulares.

O campo visual exhibe predominantemente eritrócitos (glóbulos vermelhos), com alguns elementos
menores visíveis.

É importante notar que a imagem apresentada **não** corresponde a uma Tomografia
Computadorizada, contrariando o tipo de exame indicado no contexto clínico.

... [continua no sistema]

PRESCRIÇÃO MÉDICA

PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Considerando a urgência e a alta probabilidade de malária por *Plasmodium falciparum*, o tratamento deve ser iniciado imediatamente em ambiente hospitalar, com transição para terapia oral assim que houver melhora clínica e tolerância.

• ARTESUNATO INJETÁVEL**

- Princípio Ativo:** Artesunato (como sal de sódio).
- Forma:** Pó liofilizado para solução injetável (ex: 60 mg/ampola).
- Dosagem:** 2.4 mg/kg de peso corporal.
- Via de Administração:** Intravenosa (IV) ou Intramuscular (IM).
- Frequência:** Dose inicial na hora 0, segunda dose 12 horas após, terceira dose 24 horas após a primeira, e subsequentemente uma vez ao dia (a cada 24 horas).
- Duração do Tratamento:** Administrar por pelo menos 24 horas (mínimo de 3 doses) ou até que o paciente consiga tolerar a medicação oral de forma confiável.
- Quantidade Total:** Suficiente para as doses iniciais e até a transição para terapia oral, conforme avaliação médica contínua em ambiente hospitalar (aproximadamente 3-5 ampolas de 60mg/ampola, ajustado ao peso do paciente).
- Observação:** Administração estritamente hospitalar e sob supervisão médica.

• ARTEMETHER + LUMEFANTRINA (Ex: Coartem®, Riamet®)**

- Princípio Ativo:** Artemether 20 mg + Lumefantrina 120 mg.
- Forma:** Comprimidos.
- Dosagem:** 4 comprimidos por dose.
- Via de Administração:** Oral.
- Frequência:** Administrar um total de 6 doses, conforme o seguinte esquema:
- Dose 1:** Iniciar o tratamento assim que possível, preferencialmente após a estabilização com Artesunato IV/IM.
- Dose 2:** 8 horas após a Dose 1.
- Dose 3:** 12 horas após a Dose 2 (no segundo dia de tratamento).
- Dose 4:** 12 horas após a Dose 3.
- Dose 5:** 12 horas após a Dose 4 (no terceiro dia de tratamento).
- Dose 6:** 12 horas após a Dose 5.
- Duração do Tratamento:** 3 dias (total de 6 doses).

- Quantidade Total a ser Dispensada:** 24 comprimidos (para completar as 6 doses do tratamento).
- Observação:** Deve ser tomado com alimentos ou bebidas ricas em gordura (leite, iogurte, etc.) para melhor absorção. Em caso de vômito dentro de 1 hora após a administração, uma dose adicional deve ser tomada.
-
- Internação Hospitalar Urgente:** O paciente deve ser internado imediatamente para o início do tratamento e monitoramento contínuo, dada a classificação de emergência e o risco de malária grave por *P. falciparum*.
- Confirmação Diagnóstica e Quantificação:**
 - Realizar imediatamente lâmina de gota espessa e esfregaço sanguíneo fino para confirmação da espécie de *Plasmodium* e quantificação precisa da parasitemia (densidade parasitária). Repetir conforme indicação médica para monitorar a resposta ao tratamento.
- Exames Laboratoriais Adicionais:**
 - Hemograma Completo (CBC):** Para avaliar o grau de anemia (devido à hipocromia e aniso-poiquilocitose observadas) e a contagem de plaquetas (trombocitopenia é comum).
 - Função Renal e Hepática:** Ureia, creatinina, bilirrubinas, TGO, TGP, para monitorar possíveis complicações orgânicas.
 - Eletrólitos:** Sódio, potássio, cálcio.
 - Glicose e Lactato:** Para identificar hipoglicemia e acidose metabólica, marcadores de malária grave.
 - Hidratação:** Manter hidratação adequada, inicialmente por via intravenosa, e posteriormente por via oral.
 - Repouso:** Repouso absoluto durante a fase aguda da doença.

6. **Monitoramento Intensivo:**

- Monitorar sinais vitais (pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura) regularmente.
- Avaliar o nível de consciência (Escala de Coma de Glasgow), sinais de insuficiência renal (débito urinário), icterícia, anemia severa, hipoglicemia e sinais de hiperparasitemia.
- Qualquer sinal de agravamento deve ser comunicado à equipe médica imediatamente.

7. **Dieta:** Dieta leve, de fácil digestão, rica em carboidratos e proteínas, se tolerada. Incentivar a ingestão de líquidos.

8. **Sinais de Alerta para Retornar ao Médico/Emergência:**

- Febre persistente ou recorrente após o início do tratamento.
- Piora do estado geral, confusão mental, sonolência excessiva.

- Dor de cabeça intensa ou convulsões.
- Dificuldade para respirar.
- Pele ou olhos amarelados (icterícia).
- Diminuição do volume urinário.
- Sangramentos inesperados.
- Vômitos incontroláveis que impeçam a ingestão de medicamentos orais.

9. ****Retorno:**** O paciente deverá permanecer internado até estabilização clínica e laboratorial. Após a alta hospitalar, agendar retorno para acompanhamento em 7 dias ou conforme orientação da equipe médica.

-

- **Adesão ao Tratamento:**** É fundamental seguir rigorosamente as orientações de dosagem e horários dos medicamentos para garantir a eficácia do tratamento e evitar o desenvolvimento de resistência parasitária.

- **Efeitos Colaterais Comuns:**** Os medicamentos antimaláricos podem causar náuseas, vômitos, dor abdominal, tontura e cefaleia. Informe a equipe médica se os efeitos forem intensos ou persistentes.

- **Interações Medicamentosas:**** Informar o médico sobre todos os medicamentos em uso (incluindo suplementos e fitoterápicos) para evitar interações. Artemether/Lumefantrina pode interagir com medicamentos que afetam o CYP3A4.

- **Contraindicações:**** Hipersensibilidade conhecida aos componentes das medicações. Usar com cautela em pacientes com arritmias cardíacas pré-existentes.

- **Armazenamento:**** Manter os medicamentos em local fresco e seco, protegidos da luz solar direta, e fora do alcance de crianças.

-

- **Assinatura do Médico:****

Dr. Fernando

Clínico Geral

CRM-SP 000000

- **Carimbo do Consultório:****

[Inserir carimbo do consultório aqui]

- **Informações de Contato:****

[Telefone do Consultório/Hospital]

[Endereço do Consultório/Hospital]

RECOMENDAÇÕES

RECOMENDAÇÕES MÉDICAS ESPECÍFICAS

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

IMPORTANTE:

Esta receita foi baseada no diagnóstico completo do paciente. Em caso de dúvidas, consultar o médico prescritor.

fernando

CRM: CRM-SP 000000

Clínico Geral

Receita gerada em 09/02/2026 15:22

ID da receita: 2

Sistema Médico - Receita eletrônica